

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SIS · ESCALA DE INTENCIONALIDAD SUICIDA DE BECK

Suicide Intent Scale – Evaluación heteroaplicada estandarizada de circunstancias objetivas, premeditación y expectativas en tentativas de suicidio

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Suicide Intent Scale (SIS)
Nombre en español	Escala de Intencionalidad Suicida de Beck
Sigla oficial	SIS
Autores originales	Aaron T. Beck, Dean Schuyler e Irene Herman (1974)
Adaptación hispanohablante	Julio Bobes et al. (2002); Ferran Viñas-Poch et al. (2004); Banco CIBERSAM
Año de publicación original	1974 (validación española en 2002 y 2004)
Constructo primario	Gravedad de la intencionalidad de morir, letalidad esperada, premeditación y precauciones contra el rescate
Formato de administración	Heteroaplicada mediante entrevista clínica semiestructurada e informe colateral tras tentativa
Población diana	Pacientes adolescentes y adultos (≥ 14 años) ingresados tras un intento de suicidio reciente
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (20 ítems puntuados de 0 a 2)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de dominio público con fines asistenciales y hospitalarios

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala de Intencionalidad Suicida de Beck** (SIS) es el instrumento de referencia internacional diseñado por Aaron T. Beck y su equipo en la Universidad de Pensilvania para evaluar de manera rigurosa la intensidad del deseo de morir en personas que han sobrevivido a un intento de suicidio. El modelo teórico de Beck postula una distinción conceptual crítica: la letalidad médica o daño físico objetivo del método (**medical lethality**) a menudo no se correlaciona con la intencionalidad subjetiva del paciente (**suicidal intent**), ya que una persona con una determinación firme e inminente de morir puede ingerir una sustancia inocua creyendo erróneamente que es mortal.

Por consiguiente, la SIS sitúa el foco pronóstico en la reconstrucción analítica del episodio: las precauciones activas tomadas para evitar ser descubierto (trancas en puertas, aislamiento premeditado, elección de horas sin tránsito), los actos finales definitivos (redacción de testamentos, cesión de posesiones, cartas de despedida), las expectativas subjetivas sobre la letalidad del método y la reacción afectiva ante el fracaso del intento. Múltiples estudios longitudinales han demostrado que la puntuación de la SIS en el momento de la tentativa es el predictor más potente de reintentos letales consumados a los 6 y 12 meses de seguimiento.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Parte / Dimensión Clínica	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
Parte I: Circunstancias Objetivas	8 ítems	0 – 16	Aislamiento físico, probabilidad de rescate, precauciones activas, búsqueda de auxilio, actos finales, notas y avisos previos (ítems 1 a 8).
Parte II: Expectativas y Deseos	7 ítems	0 – 14	Propósito de escape existencial, creencia sobre la letalidad, certidumbre de morir, premeditación y firmeza de la decisión (ítems 9 a 15).
Parte III: Factores Contextuales	5 ítems	0 – 10	Reacción ante el fracaso (rabia vs. arrepentimiento), concepto de muerte, antecedentes de tentativas y consumo de tóxicos (ítems 16 a 20).
Puntuación Estándar (I + II)	15 ítems	0 – 30	Escala clínica oficial de intencionalidad (ítems 1 al 15). Corte estandarizado.
Puntuación Total Ampliada	20 ítems	0 – 40	Suma completa de los 20 ítems incorporando contexto contextual y consumo de sustancias.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna (Partes I y II)	Alpha de Cronbach = 0.82 – 0.87	Buena coherencia interna en pacientes atendidos en urgencias hospitalarias en España.
Fiabilidad interjueces	CCI = 0.88 – 0.94	Elevadísima concordancia entre psiquiatras tras entrevista estructurada con el paciente y familiares.
Predicción de reintentos letales	Hazard Ratio = 2.8 – 3.4 ($p < 0.001$)	Puntuaciones en rango alto (≥ 20) predicen fuertemente el suicidio consumado a medio plazo.
Validez concurrente	$r = 0.62$ con BHS (Desesperanza); $r = 0.58$ con BSS	Correlación positiva robusta con escalas de desesperanza e ideación suicida.
Validez discriminante	$F = 42.1, p < 0.0001$	Diferencia nítidamente gestos parasuicidas impulsivos frente a actos altamente planificados.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Calificación tripartita por ítem:** Cada uno de los ítems se puntúa de 0 a 2 según descripciones operativas precisas (0 = Mínima intencionalidad / Circunstancias favorables al rescate; 1 = Intermedio o dudoso; 2 = Máxima intencionalidad / Planificación estricta).
- **Puntuación de Intencionalidad Estándar (Ítems 1 al 15):**
 - Suma directa de los 8 ítems de la Parte I (0 a 16) y los 7 ítems de la Parte II (0 a 14).
 - Rango clínico estándar: **0 a 30 puntos**. Esta es la medida universal empleada en la literatura científica para estratificar el riesgo de repetición.
- **Puntuación Total Ampliada (Ítems 1 al 20):** Suma de las tres secciones (rango 0 a 40 puntos).
- **Ítems de Alarma Máxima:** Puntuaciones de 2 en los ítems 3 (**precauciones activas contra el descubrimiento**), 5 (**actos finales/testamento**) o 16 (**rechazo y enfado por haber sobrevivido**) constituyen signos inequívocos de intencionalidad extrema.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación (1-15)	Nivel de Intencionalidad	Significación Clínica y Pronóstico Asistencial
0 – 9 puntos	Intencionalidad Baja	Tentativa impulsiva o reactiva con alta probabilidad de rescate y ambivalencia. Riesgo de repetición inmediata bajo-moderado.
10 – 19 puntos	Intencionalidad Media	Planificación intermedia o creencias mixtas sobre la letalidad. Requiere ingreso breve o derivación preferente con supervisión estrecha.
20 – 30 puntos	Intencionalidad Alta / Crítica	Riesgo extremo de repetición letal consumada. Aislamiento meticuloso, actos finales y convicción de muerte. Indicación de ingreso psiquiátrico urgente.

REGLA ASISTENCIAL EN URGENCIAS (BECK ET AL., 1974): Una puntuación ≥ 20 puntos en la SIS obliga formalmente al facultativo a plantear el ingreso involuntario urgente si el paciente rechaza la hospitalización voluntaria, dado que el riesgo de consumación letal en los primeros 30 días es crítico.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Aplicación tras la estabilización médica de la tentativa:

- Entrevistar al paciente en la Unidad de Observación de Urgencias o UCI tan pronto como recupere la orientación y el contacto verbal. Contrastar datos con familiares y atestado policial/ambulancia.

Paso 2: Evaluación cualitativa de la reacción ante la supervivencia (Ítem 16):

- Si el paciente manifiesta arrepentimiento genuino y alivio por haber sobrevivido, el riesgo disminuye.
- Si expresa rabia, frustración o promete volver a intentarlo ("la próxima vez no fallaré"), el riesgo es máximo.

Paso 3: Vía de derivación asistencial:

- SIS < 10 con buen soporte y arrepentimiento:** Valoración del plan de seguridad familiar y derivación en 48-72 horas a Salud Mental ambulatoria.
- SIS 10 – 19:** Ingreso en Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría o seguimiento ambulatorio muy intensivo con custodia familiar permanente.
- SIS ≥ 20 o ítem 16 = 2:** Ingreso psiquiátrico cerrado obligatorio en Unidad de Agudos. Monitorización de conducta suicida 1:1.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 54 años, directivo de banca prejubilado, rescatado en coma en su garaje con el motor del coche encendido y una ingesta masiva de barbitúricos. Tras 48 horas en UCI y extubación, es evaluado por el psiquiatra de enlace.

Puntuaciones en la Escala SIS de Beck:

- Puntuación Estándar (Ítems 1-15): 26 puntos / 30** (Intencionalidad Alta / Crítica).
- Parte I (Circunstancias): Aislamiento absoluto en sótano cerrado (2), hora intempestiva (2), puerta atrancada por dentro (2), no pidió ayuda (2), dejó carta manuscrita y testamento actualizado en la mesa (2), no avisó verbalmente (2).
- Parte II (Expectativas): Deseaba poner fin a su vida (2), seguro de morir (2), método preparado meticulosamente durante 2 semanas (2).
- Ítem 16: Puntúa 2 (afirma sentirse muy enfadado con el equipo de rescate por haberlo encontrado).

Decisión y Plan Asistencial: A pesar de que el paciente intentaba mostrarse tranquilo para solicitar el alta domiciliaria, la SIS desarticuló la minimización, revelando un intento de suicidio de máxima planificación y letalidad. Se tramitó inmediatamente el ingreso involuntario urgente en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. Se inició tratamiento con Litio y terapia de reestructuración cognitiva de desesperanza, logrando tras 4 semanas de ingreso la estabilización de su ánimo y la vinculación a un plan de vida adaptativo.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE RIESGO MORTAL:

- Discrepancia daño físico / intención:** No subestimar intentos con daño físico leve si las precauciones y la creencia subjetiva de muerte eran absolutas.
- Falso arrepentimiento complaciente:** Desconfiar de la docilidad repentina de pacientes con SIS previa alta que buscan el alta para consumir el acto.
- Consumo de alcohol facilitador (Ítem 19 = 2):** Beber deliberadamente para atreverse es indicativo de determinación letal irreprimible.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- Tentativa suicida vs. Autolesión no suicida (NSSI):** La autolesión busca regular el afecto negativo sin intención de morir; la SIS exige evaluar el deseo explícito de cese vital.
- Gestos manipulativos en TLP:** Suelen presentar baja premeditación, llamadas de aviso y nulas precauciones contra el descubrimiento (SIS < 10).
- Psicosis con órdenes alucinatorias:** Distinguir entre ideación depresiva estructurada y conducta guiada por alucinaciones imperativas.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

- Beck, A. T., Schuyler, D., & Herman, I. (1974). Development of suicidal intent scales. In A. T. Beck, H. L. P. Resnik, & D. J. Lettieri (Eds.), **The prediction of suicide** (pp. 45–56). Charles Press Publishers.
- Viñas-Poch, F., Villar-Hoz, E., Caparrós-Caparrós, B., Juan-Ferrer, J., Cornella-Font, M., & Pérez-Prat, I. (2004). Intentos de suicidio en la adolescencia: factores de riesgo y seguimiento. *Psicothema*, 16(4), 577–583.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2002). **Escala de Intencionalidad Suicida de Beck (SIS): Manual de validación en español**. Universidad de Oviedo / CIBERSAM.
- Harriss, L., & Hawton, K. (2005). Suicidal intent in deliberate self-harm and the risk of subsequent suicide: the predictive validity of the Suicide Intent Scale. *British Journal of Psychiatry*, 186(5), 393–398. <https://doi.org/10.1192/bjp.186.5.393>